

Dra Valéria Nogueira Tobias Granja Neuropediatra
CRM 4069 RQE 1899



ESTER BERNARDINO PEREIRA DN 13/08/2023 ID 2 anos 8 meses

Criança avaliada por alteração em linguagem e comportamento.

Nasceu sem intercorrências de parto cesariana. Termo. Chorou ao nascer. Alta do berçário após 2 dias.

Marcos motores alcançados dentro da normalidade. Introdução alimentar sem dificuldades. Iniciou intervenção precoce com fonoaudiólogo por dificuldades no desenvolvimento da linguagem. Aos 2 anos não apresentava linguagem efetiva, apenas palavras soltas. Diante de episódios de frustração jogava-se no chão com episódios de birras. Inflexibilidade comportamental. Em casa apresentava busca pelo movimento subindo em móveis sem noção do perigo. Assim como dificuldades na interação nas brincadeiras com outras crianças. Limitação nas trocas sociais recíprocas.

Durante avaliação clínica apresentou baixa interação com examinador e baixo contato visual. Não foi capaz de dizer o próprio nome ou idade. Dificuldade de execução de comandos simples como mostrar partes do corpo diante da solicitação do examinador. Enfileirou brinquedos. Linguagem receptiva e expressiva comprometidas. Presença de tchau estereotipado. Baixa iniciativa na comunicação verbal e não verbal. Presença de dificuldades na interação social recíproca, na comunicação social e flexibilidade comportamental. Sintomas de transtorno do espectro autista (TEA).

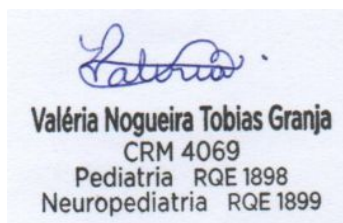
Solicitada avaliação neuropsicológica realizada por Dra Maria Fabiana Lisboa com resultado compatível com TEA. Obteve ponto de corte nas escalas de rastreio diagnóstico. Na escala de traços autísticos (ATA) obteve pontuação de 30. Na

escala CARS obteve pontuação de 31,5. No PROTEA-R apresentou prejuízos importantes nos domínios relacionados à comunicação social, interação social recíproca e padrões comportamentais restritos e repetitivos. ADOS-2 com achados consistentes e compatíveis com o transtorno do espectro autista.

No inventário Portage apresentou comprometimento nas áreas cognitiva (37% para sua faixa etária), socialização/comportamento(62% para sua faixa etária), linguagem/comunicação (6% para sua faixa etária) e autocuidados(69% para sua faixa etária). No inventário IDADI apresentou rendimento abaixo da média nos domínios socioemocionais estando na média apenas domínio cognitivo.

Criança apresenta critérios diagnósticos do DSM-5 (2013) para Transtorno do Espectro Autista. Presença de **TODOS os critérios A: déficits persistentes na comunicação e interação social, com limitação na reciprocidade emocional e social, limitação nos comportamentos de comunicação não verbal e limitações em iniciar, manter e entender relacionamentos.** Do critério B apresenta **padrões repetitivos e restritos de comportamento com movimentos motores, inflexibilidade comportamental e perfil sensorial alterado.**

CID F 84.0



Maceió, 12 de maio de 2026.

Dra Valéria Nogueira Tobias Granja Neuropediatra
CRM 4069 RQE 1899



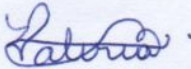
ESTER BERNARDINO PEREIRA DN 13/08/2023 ID 2 anos 8 meses

Criança portadora de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Necessita acompanhamento com equipe multidisciplinar especializada no tratamento do TEA. Solicito :

- **Intervenção em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) realizado por psicólogo - 10 horas semanais.**
- **Fonoaudiologia - 2 horas semanais.**
- **Terapia Ocupacional (Integração Sensorial) 2 horas semanais**
- **Musicoterapia 2 horas semanais.**

CID F 84.0


Valéria Nogueira Tobias Granja
CRM 4069
Pediatria RQE 1898
Neuropediatria RQE 1899

Maceió, 12 de maio de 2026.



FabianaLisboa

PSICÓLOGA/NEUROPSICÓLOGA
MESTRA EM EDUCAÇÃO - UNISUL
CRP 15/3115

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Psicóloga Responsável: Maria Fabiana Lisboa (CRP 153115)

Ester Bernadino Pereira

Psicóloga Clínica Infanto-juvenil
Analista do Comportamento – ABA
Esp. em Desenvolvimento Infantil e TEA
e Avaliação Neuropsicológica.

Evoluir Espaço Terapêutico
Rua Professor Virgínio de Campos,
Nº 710, Farol. Maceió – AL.

(82) 98821-6324
@fabianalisboa3
fabianalisboa.com.br

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Psicóloga Responsável: Maria Fabiana Lisboa (CRP 153115)

Solicitante: Dra. Edna – Pediatra e Dra. Valeria Nogueira - Neuropediatra

I. IDENTIFICAÇÃO

Nome: Ester Bernadino Pereira

Data de Nascimento: 13/08/2023 - **Idade:** 2 anos

Sexo: Feminino **Escola:** Rosalvo Felix

Mãe: Thaynan Bernadino da Silva Pedrosa

Pai: Paulo Felipe L. Pedrosa Pereira

II. FINALIDADE

Solicitação de Avaliação Neuropsicológica com enfoque diagnóstico.

II.1 QUEIXA

Estereotipias motoras, atraso de fala, rebaixamento de contato visual, dificuldade de socialização.

III. HIPÓTESE DIAGNÓSTICA INVESTIGADA

6A02.3 – Transtorno do Espectro Autista- TEA?

IV. ANTECEDENTES RELEVANTES

Ester é a segunda filha do casal, fruto de uma gestação sem intercorrências clínicas relevantes. O parto ocorreu por via cesariana, com 39 semanas e 4 dias de idade gestacional. Segundo relato dos pais, o aleitamento materno ocorreu até os 2 anos e 6 meses de idade, sendo o processo de desmame realizado de maneira gradual. A introdução alimentar ocorreu aos seis meses, apresentando boa aceitação alimentar, consumindo variados tipos de alimentos. Atualmente, senta-se à mesa durante as refeições, já demonstrando tentativas de utilização de talheres.

No que se refere ao sono, os pais relatam padrão considerado adequado, dormindo geralmente por volta das 19h e despertando às 5h da manhã. Relatam ainda que, ao acordar cedo, Ester costuma dirigir-se sozinha à cozinha, tentando buscar alternativas para se alimentar, apesar da idade atual de 2 anos e 7 meses. Habitualmente realiza um segundo período de sono por volta das 11h, antes de ir para a escola.

Quanto aos marcos do neurodesenvolvimento, engatinhou por volta dos sete meses de idade e iniciou marcha independente com aproximadamente 1 ano e duas semanas. Entretanto, os pais referem atraso no desenvolvimento da linguagem. Relatam que Ester chegou a emitir palavras isoladas como “mamãe”, “papá” e algumas vocalizações, porém sem evolução funcional espontânea da comunicação verbal naquele período. Apesar disso, apontava para objetos de interesse e demonstrava compreensão de comandos simples. Segundo os responsáveis, após início de intervenção fonoaudiológica houve melhora gradual na comunicação, embora ainda necessite de incentivo frequente para utilização da linguagem verbal funcional.

Os pais relatam que, diante de situações de frustração ou dificuldade em comunicar desejos e necessidades, Ester costuma jogar-se ao chão e apresentar episódios de birra. Em contextos sociais, como momentos de brincadeira no prêdio, tende a explorar o ambiente de maneira mais independente, demonstrando pouco interesse em permanecer integrada ao grupo de crianças. Aproxima-se mais quando as brincadeiras envolvem correr ou atividades com maior estimulação motora, porém geralmente prefere subir em árvores, correr pelo ambiente e manter-se em constante movimento.

Ester possui uma irmã de seis anos, entretanto, segundo os pais, ambas interagem pouco em brincadeiras compartilhadas, principalmente devido às dificuldades de linguagem apresentadas por Ester. Observa-se maior preferência por brincadeiras solitárias, corridas pelo ambiente, utilização de blocos de montar, urso de pelúcia e brincadeiras funcionais.

No aspecto sensorial e das atividades de vida diária, os pais referem resistência durante a lavagem dos cabelos, apresentando inquietação nesses momentos. Escova os dentes, porém ainda faz uso de fraldas. Relatam que costuma reter a urina, realizando micção apenas quando a fralda é colocada. Quanto ao controle esfinteriano intestinal, evacua na fralda e posteriormente retira a mesma para mostrar aos pais o conteúdo fecal.

Os responsáveis descrevem ainda comportamento frequente de subir em móveis e escalar objetos para alcançar aquilo que deseja, preferindo estratégias motoras independentes ao invés de solicitar ajuda de adultos. Em alguns comandos, necessita de modelo gestual associado à orientação verbal para conseguir iniciar a ação solicitada. Demonstram também que Ester apresenta importante interesse por músicas, além de realizar imitação de sons e comportamentos de animais.

No histórico terapêutico, iniciou acompanhamento fonoaudiológico por volta dos 2 anos e 3 meses de idade. Segundo os pais, inicialmente não perceberam evolução significativa, ocorrendo posteriormente troca de profissional em dezembro de 2025 e nova mudança em janeiro subsequente, momento em que passaram a observar início de emissão de novas palavras.

A vida escolar iniciou-se aos 2 anos e 5 meses, sendo marcado inicialmente por episódios de choro e necessidade de suporte para adaptação. Conforme relatório escolar apresentado pelos pais, Ester demonstra preferência pela comunicação não verbal, interesse acentuado por televisão, músicas e recursos visuais, apresentando hiperfoco nesses estímulos, o que torna desafiador o redirecionamento para outras atividades propostas em sala. O documento escolar aponta ainda pouco interesse em atividades em pares ou coletivas, tendência ao isolamento, dificuldade no contato visual, ausência de noção de perigo, baixa tolerância à frustração, episódios de birra e reações impulsivas, expressando emoções de maneira intensa e frequentemente necessitando de manejo por parte da professora.

Diante das características observadas no desenvolvimento e comportamento, durante consulta pediátrica os pais foram orientados a buscar avaliação especializada com neuropediatra, que posteriormente realizou encaminhamento para avaliação neuropsicológica.

V. INSTRUMENTOS E ETAPAS DA AVALIAÇÃO

- *Anamnese Psicológica*
- Observação clínica
- Momento Lúdico
- Visita Escolar
- *ATA- Escala de Traços Autístico*
- CARS
- ADOS 2
- SRS- 2
- Protea-r
- Denver II
- IDADI
- PORTAGE
- BAYLEY
- Entrevista devolutiva

VI. DADOS DA OBSERVAÇÃO CLÍNICA E MOMENTO LÚDICO

Durante as sessões avaliativas, Ester esteve acompanhada por um dos responsáveis. Nos momentos iniciais dos atendimentos, apresentava episódios de choro e necessidade de condução pelos pais até o setting terapêutico. Entretanto, observou-se que, após a entrada na sala e o afastamento dos responsáveis, o choro cessava rapidamente, sem manutenção prolongada do comportamento de protesto. Ao longo das sessões, demonstrou compreensão de comandos simples, especialmente quando acompanhados de modelo gestual. Contudo, observou-se baixa responsividade às solicitações da avaliadora, realizando os comandos predominantemente quando compatíveis com seus interesses imediatos, necessitando frequentemente de insistência e mediação para adesão às atividades propostas.

Ester apresentou importante tendência ao brincar solitário, demonstrando incômodo quando a avaliadora tentava interferir, compartilhar ou ampliar as situações lúdicas propostas. Durante os momentos livres, permaneceu predominantemente envolvida com brinquedos de encaixe e montagem, especialmente blocos tipo lego, realizando manipulações repetitivas e apresentando dificuldade para transitar entre atividades ou flexibilizar interesses.

Observou-se postura frequente em posição de “W”, além da presença de movimentos estereotipados motores, como flapping de mãos em momentos de excitação. Também foi observado padrão frequente de marcha na ponta dos pés e comportamento de vagar pela sala, deslocando-se constantemente entre diferentes espaços do ambiente terapêutico. Ester demonstrou tendência a escalar móveis e objetos da sala para acessar itens de interesse, utilizando pouco a comunicação funcional para solicitar ajuda ou expressar necessidades. Embora tenha apresentado resposta ao

ser chamada pelo nome em diferentes ocasiões, mostrou baixa aceitação ao direcionamento do adulto, resistindo frequentemente às tentativas de condução das atividades.

No aspecto motor, apresentou boa coordenação óculo-manual, especialmente em atividades de encaixe e manipulação de objetos. Durante as brincadeiras, observou-se presença de brincadeira funcional e alguns momentos de interação conjunta mediada, porém sem presença consistente de brincadeira simbólica espontânea. Demonstrou ainda dificuldade em compartilhar objetos, turnos e interesses durante as interações.

Quanto à linguagem, emitiu algumas palavras isoladas ao longo das sessões, entretanto observou-se presença de ecolalia imediata. Não respondeu adequadamente a perguntas simples e apresentou necessidade de insistência significativa para utilização de apontar funcional, imitação de sons de animais e execução de ações imitativas. Observou-se forte tendência à manutenção de padrões repetitivos de brincadeiras e preferência restrita por determinados brinquedos. Quando havia tentativa de mudança da atividade ou interrupção de interesses preferenciais, Ester apresentava comportamentos de desorganização emocional, incluindo jogar objetos no chão, chorar e jogar-se ao solo.

Apesar das dificuldades observadas, demonstrou capacidade de guardar brinquedos quando solicitada mediante direcionamento do adulto. Também apresentou reconhecimento de cores e habilidades de encaixe, embora a execução dessas habilidades ocorresse predominantemente em situações espontâneas e não necessariamente sob comando direto. No aspecto sensorial, observou-se hipersensibilidade tátil, especialmente diante de estímulos como côdegas, reagindo de maneira exacerbada e chegando a apresentar comportamento de bater na avaliadora em resposta ao desconforto percebido.

As principais aproximações sociais observadas ocorreram mediadas por músicas, brinquedos de encaixe ou recursos de causa e efeito. Nas atividades que envolviam estímulos musicais, Ester demonstrava maior engajamento, sorriso social e permanência compartilhada com a avaliadora. Entretanto, apresentava irritabilidade quando percebia tentativas de interação consideradas invasivas ou excessivamente direcionadas.

Foi realizado ainda momento de **observação em ambiente escolar**. Durante este contexto, Ester apresentou comportamentos semelhantes aos observados no setting terapêutico. Demonstrou pouca percepção e participação em relação ao que acontecia ao seu redor, permanecendo grande parte do tempo em brincadeiras solitárias ou vagando pela sala. Observou-se novamente marcha na ponta dos pés e baixa participação espontânea nas atividades coletivas. Durante os momentos de brincadeira em grupo, permanecia fisicamente próxima aos colegas, porém sem efetivamente compartilhar brincadeiras ou estabelecer trocas sociais recíprocas. Nas atividades em roda, não seguia espontaneamente os comandos da professora, necessitando frequentemente de manejo direto, incluindo colo, modelagem comportamental e recondução constante às atividades propostas.

Observou-se maior interesse e engajamento quando a televisão da sala foi ligada com estímulos musicais. Nesses momentos, Ester cantava, olhava atentamente para a televisão e imitava coreografias apresentadas no vídeo, embora frequentemente permanecesse de costas para a professora e sem troca efetiva com os demais colegas. Diferentemente das outras crianças da turma, aparentou não demonstrar curiosidade ou incômodo significativo diante da presença da avaliadora observando pelo vidro da sala, mesmo tratando-se de pessoa pouco familiar ao

ambiente escolar. Em diversos momentos, a professora e a auxiliar necessitaram redirecioná-la para atividades coletivas, roda ou tarefas propostas ao grupo.

Apresentou fixação por objetos do tipo “squishy”, demonstrando desorganização emocional quando solicitada a guardá-los. Também foi observado que Ester não acompanhava espontaneamente a fila junto aos demais colegas, demonstrando dificuldade em compreender e acompanhar a rotina escolar sem apoio constante de adultos. Em diálogo com a coordenação escolar, foram pontuadas dificuldades significativas relacionadas à interação social, compreensão e cumprimento de regras, sendo relatado que a escola vem buscando estratégias de manejo e suporte para favorecer sua participação e adaptação no contexto escolar.

VII. DADOS QUANTITATIVOS DA AVALIAÇÃO

- **Critérios de avaliação do desenvolvimento infantil, comportamento adaptativo e inteligência.**

- **DENVER II.**

Teste de triagem de desenvolvimento, usado para identificar a criança cujo desenvolvimento parece estar atrasado em comparação com outras crianças. Mensura o desenvolvimento infantil nas quatro áreas do desenvolvimento: pessoal social, motor-fino adaptativo, linguagem e motor grosso. De acordo com o teste Ester apresentou um total de **10 falhas para os itens testados para seu limite de idade**. Assim os resultados do teste evidenciaram, 05 falhas na área pessoal social e 05 falhas na área da linguagem. Assim o teste destacou um **desenvolvimento infantil com atraso**.

- **INVENTÁRIO PORTAGE OPERACIONALIZADO**

O inventário Portage possibilita uma avaliação em cinco áreas do desenvolvimento infantil. Ester foi avaliada nas 5 áreas do inventário. As faixas etárias escolhidas para iniciar a avaliação foram as de **0 a 1 ano, 1 a 2 anos e 2 a 3 anos**.

Áreas observadas:

- Desenvolvimento Motor, Autocuidados, linguagem, socialização e Cognição.

Índices de fidedignidade global: 95%

Aprovação da área: Necessário atingir 80% para concluir que a criança superou a fase de desenvolvimento avaliada.

RESULTADOS:

DOMÍNIO	0 A 1	1 A 2	2 a 3 anos	CLASSIFICAÇÃO
Socialização/comportamento	85%	60%	62%	ATRASO
Linguagem/comunicação	80%	50%	6%	ATRASO
Cognição	92%	70%	37%%	ATRASO
Motor	100%	100%	87%	TÍPICO
Autocuidado	100%	91%	69%	ALERTA PARA ATRASO

ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS DO INVENTÁRIO PORTAGE:

De acordo com os resultados encontrados no inventário Portage, fica claro que a criança apresenta atrasos no percurso do desenvolvimento, necessitando de intervenções. Ester apontou atrasos nas áreas sociocomunicativas de maneira relevante. Cabe destacar que a área de autocuidado é respondida junto aos responsáveis.

• IDADI – INVENTÁRIO DIMENSIONAL DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.

O IDADI avalia por meio do relato dos pais os sete domínios de desenvolvimento: Cognitivo, socioemocional, comunicação e linguagem expressiva, motricidade ampla, motricidade fina e comportamento adaptativo. De acordo com o inventário, Ester apresenta os seguintes resultados considerando a sua faixa etária:

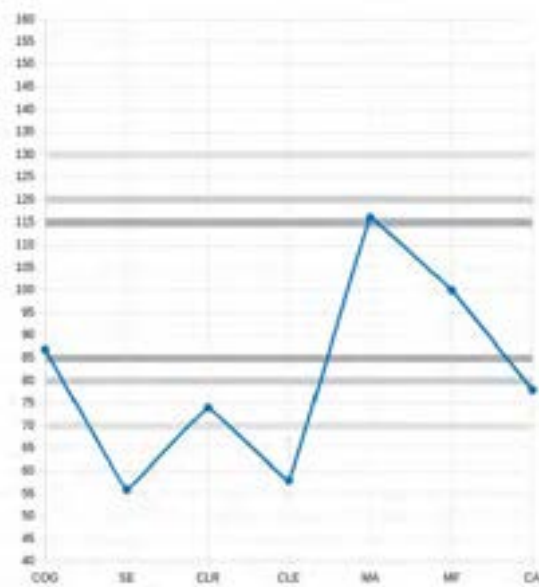
Classificação e Interpretação dos Escores Padronizados e Escores Z

Domínios	Classificação	Interpretação
Cognitivo	Médio	Típico
Socioemocional	Muito Inferior	Atraso significativo
Comunicação e Linguagem Receptiva	Inferior	Atraso
Comunicação e Linguagem Expressiva	Muito Inferior	Atraso significativo
Motricidade Ampla	Acima da Média	Típico
Motricidade Fina	Médio	Típico
Comportamento Adaptivo	Abaixo da Média	Alerta para atraso



FabianaLisboa
PSICÓLOGA/NEUROPSICÓLOGA
MESTRA EM EDUCAÇÃO - UNISUL
CRP 15/3115

Perfil dos Escores Padronizados de Desenvolvimento



Os resultados do teste IDADI – Inventário Dimensional de Avaliação Infantil do Desenvolvimento Infantil, demonstram **rendimento abaixo da média nos domínios socioemocionais, estando na média apenas nos aspectos de cognição, motor grosso e motricidade fina**. Cabe destacar que esse inventário, conta com 100% das respostas fornecidas pelos genitores, e olhando para o gráfico, percebe-se um desempenho global com atrasos significativos.

Escala Bayley de desenvolvimento do bebê e da criança pequena

Essa escala é um instrumento administrado individualmente, que avalia o funcionamento do desenvolvimento do bebê e crianças pequenas. Tem como objetivo identificar atrasos no desenvolvimento avaliando cinco domínios: Cognitivo, linguístico (comunicação expressiva e receptiva), motor (grosso e fino), socioemocional e comportamento. Os resultados dos testes serão apresentados por meio de pontuação escalonada e interpretados em pontos ponderados com suas respectivas classificações na tabela abaixo:

1. **Análise quantitativa:**

SUBTESTES	PONTUAÇÃO BRUTA	PONTUAÇÃO ESCALONADA	CLASSIFICAÇÃO
COGNITIVO (cog)	59	06	MÉDIO INFERIOR
LINGUAGEM (ling)	**	**	**
COMUNICAÇÃO RECEPTIVA (CR)	19	05	LIMITROFE
COMUNICAÇÃO EXPRESSIVA (CE)	22	05	LIMITROFE

Psicóloga Clínica Infanto-juvenil
Analista do Comportamento – ABA
Esp. em Desenvolvimento Infantil e TEA
e Avaliação Neuropsicológica.

Evoluir Espaço Terapêutico
Rua Professor Virgínio de Campos,
Nº 710, Farol. Maceió – AL.

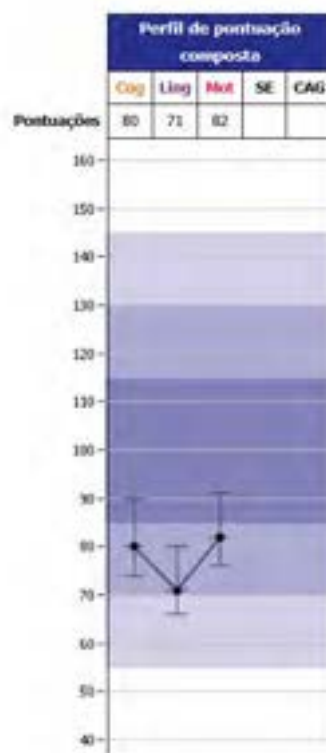
(82) 98821-6324
@fabianalisboa3
fabianalisboa.com.br



FabianaLisboa
PSICÓLOGA/NEUROPSICÓLOGA
MESTRA EM EDUCAÇÃO - UNISUL
CRP 15/3115

MOTORA (Mot)	**	**	**
MOTRICIDADE FINA (MF)	42	09	MÉDIO
MOTRICIDADE GROSSA (MG)	51	05	LIMITROFE

GRÁFICO GERAL ESCALA BAYLEY:



ESCALA COGNITIVA: Avalia uma construção uniforme, logo, não tem Subtestes separados, sua ênfase recai sobre a avaliação do desenvolvimento mental por meio de métodos que minimizam a linguagem, avaliando o desenvolvimento sensório-motor, exploração e a manipulação dos objetos, as relações com os objetos, a formação de conceitos e a memória, medindo também a atenção a estímulos familiares e não familiares e a solução de problemas. Ester perfaz um perfil com pontuação composta de 80, pontuação escalonada de 06, apontando um **perfil abaixo da média e sugerindo uma idade de desenvolvimento de 22 meses em relação aos aspectos cognitivos.**

ESCALA DE LINGUAGEM: Mede dois aspectos principais da linguagem: as habilidades de comunicação receptiva e expressiva. Essas habilidades são exibidas de modo diferente e podem ou não se desenvolver de forma independente. A linguagem receptiva precede a linguagem expressiva, avalia os comportamentos pré-verbais, incluindo a capacidade de reconhecer sons, o vocabulário receptivo (habilidade de identificar objetos e figuras), o desenvolvimento morfológico (pronomes e preposições) e os marcadores morfológicos, assim como referências sociais e de compreensão verbal. Ester perfaz um perfil com pontuação composta de 71, apontando uma **classificação geral limítrofe**, quando analisamos de maneira distintas a sua capacidade de **linguagem receptiva**, apontou uma pontuação escalonada de 05 estando **em classificação**

Psicóloga Clínica Infanto-juvenil
Analista do Comportamento – ABA
Esp. em Desenvolvimento Infantil e TEA
e Avaliação Neuropsicológica.

Evoluir Espaço Terapêutico
Rua Professor Virgínio de Campos,
Nº 710, Farol. Maceió – AL.

(82) 98821-6324
@fabianalisboa3
fabianalisboa.com.br

limítrofe, e pontuação escalonada de 05 em relação a linguagem/**comunicação expressiva**, apontando um perfil **limítrofe** em relação a troca de turnos, intenção comunicativa, nomeação de objetos e seus atributos quando solicitado e desenvolvimento morfofossintático, Ester aponta idade de desenvolvimento compatível com **17 meses em relação a comunicação receptiva e 18 meses e em relação a comunicação expressiva**.

ESCALA MOTORA: Avalia as habilidades motoras finas e grossas separadamente. Ester perfaz um perfil com pontuação composta de 82, apontando uma classificação geral **médio inferior**, quando analisamos de maneira distintas a sua capacidade de motora fina apontou uma pontuação escalonada de 09 estando **na classificação médio**, em relação as habilidades óculo manual, controle dos músculos dos olhos, preensão para pegar, empilhar, agrupar, construir estruturas simples, traçar e riscar, assim como rastrear visualmente um objeto, alcançar o que deseja e discriminar tatilmente um objeto ou coisa. Realizou ainda pontuação escalonada de 05 em relação a **motora grossa**, apontando um **perfil limítrofe** em relação ao movimento dos membros do corpo e do dorso, posicionamento estático, movimentação dinâmica, equilíbrio e planejamento motor, indicando idade de desenvolvimento de **28 meses em motor fino e 18 meses em motor grosso**. Cabe destacar ainda que as dificuldades em relação as questões de motor fino, ocorreram pela dificuldade de Ester em seguir comandos e executar instruções.

Esse perfil sugere um perfil global com atrasos, principalmente em linguagem e aspectos sociocomunicativos, o que corrobora com achados anteriores.

- **Testes e escalas referentes ao transtorno do Espectro Autista – TEA:**

- **Escala de Traços Autísticos – ATA**

Esta escala, embora não tenha o escopo de avaliar especificamente uma função psíquica, é utilizada para avaliação de um dos transtornos mais importantes da Psiquiatria Infantil – o TEA. Seu ponto de corte é de 15. Dos 58 pontos que a escala aponta a menor **pontuou 30** pontos, sendo eles mais evidentes nos itens: **dificuldade na interação social (iniciativa), manipulação do ambiente, resistência a mudanças, alteração da atenção, exploração dos objetos, alteração na comunicação, não manifesta habilidades e conhecimentos quando solicitado, só quando quer, reação inapropriada ante a frustração, comportamentos estereotipados e repetitivos, aparecimento dos sintomas antes dos 36 meses**.

Essa pontuação destaca características e **sinais do transtorno do espectro autista – TEA**.

- **Escala childhood autism rating scale - CARS**

Escala comportamental composta por 15 Itens, desenvolvida para identificar crianças com o Transtorno do Espectro Autista - TEA, permitindo ainda uma classificação clínica da sua gravidade desde ligeiro a moderado e severo”. Ester realiza uma soma de **31,5 pontos** divididos da seguinte forma:

ESCALA DE COTAÇÃO			
DOMÍNIOS		PONTUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
I	Relação com pessoas	2,5	
II	Imitação	2	
III	Resposta emocional	2,5	
IV	Uso corporal	2	
V	Uso de objetos	2	
VI	Adaptação à mudança	2	
VII	Resposta visual	1,5	
VIII	Resposta auditiva – ao som	1	
IX	Resposta ao paladar, olfato e tato	2	
X	Medo ou ansiedade	2	
XI	Comunicação verbal	3	
XII	Comunicação não verbal	2,5	
XIII	Nível de atividade	2,5	
XIV	Nível e consistência da resposta inte	2	
XV	Impressão global	2	
Cotação Total:		31,5	autista

Essa pontuação classifica a criança **como autista**.

- **PROTEA-R – Sistema de Avaliação da suspeita de Transtorno do Espectro Autista.**

O Sistema PROTEA-R tem como objetivo principal o rastreamento da presença de comportamentos inerentes a sintomatologia do transtorno do Espectro Autista (TEA), conhecidos como “sinais de alerta,” em crianças em torno dos 24 aos 60 meses de idade. É uma ferramenta para avaliar, sistematicamente, o comportamento infantil, em caso de suspeitas de TEA, por meio de situações semiestruturadas de brincadeiras interativas e é pautada nos critérios diagnósticos de TEA presentes no *manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – Quinta Edição, DSM-5*. De acordo com a avaliação Ester pontua um total de 08 (OITO) pontos, indicando **Risco para TEA**.

Tabela com itens Críticos avaliados:

Itens Críticos	Escala de qualidade	Escore convertido	Escala de Frequência
Iniciativa de Atenção Compartilhada	C	2	BAIXA
Resposta de Atenção Compartilhada	B	1	MÉDIA
Imitação	B	1	MÉDIA

Brincadeiras Simbólicas	C	3	BAIXA
Movimentos Repetitivos de outras partes do corpo	B	1	médio
	TOTAL	08	

Potencialidades e limitações observadas em relação aos comportamentos avaliados pelos itens do PROTEA-R:

De acordo com os dados obtidos por meio da aplicação do PROTEA-R, Ester apresentou alterações significativas nos domínios relacionados à comunicação social, interação social recíproca e padrões comportamentais restritos e repetitivos.

Observou-se que Ester é capaz de compartilhar o foco de atenção com a avaliadora, entretanto tal comportamento ocorre de maneira inconsistente e mediante necessidade de intenso estímulo e mediação do adulto. No aspecto comunicativo, utiliza predominantemente gestos e recursos não verbais para expressar desejos e necessidades, apresentando baixa iniciativa de comunicação verbal funcional. Em diversos momentos, diante de interesses específicos, opta por acessar aquilo que deseja de maneira independente, escalando móveis e objetos, ao invés de solicitar ajuda ou utilizar comunicação funcional.

Demonstrou maior engajamento interativo em situações relacionadas aos seus interesses preferenciais, especialmente em atividades envolvendo música, movimentos corporais, brinquedos de encaixe e estímulos visuais. Contudo, de forma geral, apresentou preferência por atividades solitárias, evidenciando desconforto quando a interação era direcionada ou insistida pelo adulto.

No domínio da linguagem, observam-se atrasos importantes no desenvolvimento da comunicação verbal, com presença de ecolalia imediata em diferentes contextos interativos. As habilidades imitativas mostraram-se presentes, porém inconsistentes, necessitando de insistência significativa do adulto para emissão de sons, especialmente sons de animais e ações imitativas simples. Apesar disso, demonstrou compreensão de alguns comandos simples, principalmente quando acompanhados de pistas gestuais ou modelagem comportamental.

Durante as atividades lúdicas, Ester apresentou capacidade de guardar brinquedos e realizar brincadeiras funcionais por meio de imitação de ações observadas. Entretanto, tais comportamentos ocorreram predominantemente em seu próprio ritmo e interesse, demonstrando resistência quando as solicitações eram conduzidas diretamente pelo avaliador.

No aspecto da interação social, observou-se limitação nas trocas sociais recíprocas, embora tenha apresentado momentos pontuais de imitação gestual e sorriso social, principalmente mediados por estímulos musicais. Demonstrou tendência à repetição de padrões de brincadeira e dificuldade significativa em flexibilizar ações lúdicas e aceitar mudanças propostas durante as interações. Quando convidada a modificar atividades ou interromper interesses restritos, apresentou comportamentos de desorganização emocional, incluindo jogar-se ao chão, arremessar objetos e comportamentos agressivos direcionados à avaliadora.

Ester mostrou boa aceitação em atividades que envolviam movimento, como correr, pular e brincar com música. Em contrapartida, demonstrou desconforto importante diante de determinadas interações corporais, como cócegas, reagindo de forma exacerbada ao estímulo tátil. Observou-se ainda presença de movimentos estereotipados, como flapping de mãos em momentos de excitação, especialmente diante de estímulos musicais e brinquedos giratórios.

Foram observadas dificuldades importantes em tarefas que exigiam seguimento de comandos, manutenção da atenção compartilhada e direcionamento para atividades propostas pelo adulto. Ester apresentou rigidez na condução das brincadeiras, insistindo em suas próprias formas de interação e demonstrando baixa tolerância à interferência externa.

Embora tenha evidenciado compreensão contextual de algumas situações simbólicas simples, como brincadeiras com bolhas de sabão e uso de câmera fotográfica, apresentou preferência mais consistente por atividades repetitivas, previsíveis e estruturadas, especialmente brinquedos musicais e jogos de encaixe, demonstrando dificuldade significativa nas transições entre atividades.

Durante a exploração dos materiais avaliativos, apresentou boa coordenação visuomotora e manipulação adequada dos objetos. Contudo, observou-se tendência à dispersão, baixa permanência nas atividades e dificuldade em concluir tarefas de maneira independente.

De modo geral, os resultados obtidos no PROTEA-R evidenciam indicadores comportamentais compatíveis com alterações qualitativas na comunicação social e na flexibilidade comportamental, apresentando **pontuação sugestiva para o Transtorno do Espectro Autista (TEA)**.

- **SRS – 2 – Escala de Responsividade Social**

A Escala de Responsividade Social (SRS-2), que tem como objetivo mensurar sintomas associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a classificá-los em níveis leves, moderados ou severos, Ester fez os seguintes resultados:

Na Subescala de **Percepção Social** que mede a capacidade de reconhecer pistas sociais e lidar com os aspectos da percepção do comportamento social recíproco, apresentou um escore de 59 que indica uma **classificação na norma**.

Na Subescala de **Cognição Social** que se refere a capacidade de interpretar as pistas sociais após reconhecê-las e lidar com o aspecto cognitivo-interpretativo do comportamento social recíproco, apresentou escore de 60 que apontam classificação com **alterações de nível leve**, ligada ao TEA.

Na Subescala de Intervenção de **Comunicação Social** que mede a capacidade de comunicação expressiva, lidando com os aspectos motores do comportamento social recíproco, apresentou escore de 62 que indica **um perfil com alterações de nível leve**, ligada ao TEA.

Na Subescala de **Motivação Social** que se refere ao grau em que as pessoas geralmente são motivadas a engajar em comportamento sócio interpessoal, apresentou um escore de 56, apontando **perfil sem alterações**.

Na subescala de **Intervenção Comunicação e Interação Social** que é uma medida global que se relaciona tanto à capacidade de reconhecer e interpretar sinais sociais quanto à capacidade

de motivação para o contato interpessoal social expressivo apresentou escore de 60, que indica um **perfil com alterações de nível leve ligadas ao TEA**.

Já na Subescala de **Intervenção de Padrões Restritos e Repetitivos** que mede a presença de comportamentos estereotípicos característicos de Transtorno do Espectro Autista – TEA e áreas de interesse muito limitadas, apresentou escore de 55, que indica **perfil sem alterações**.

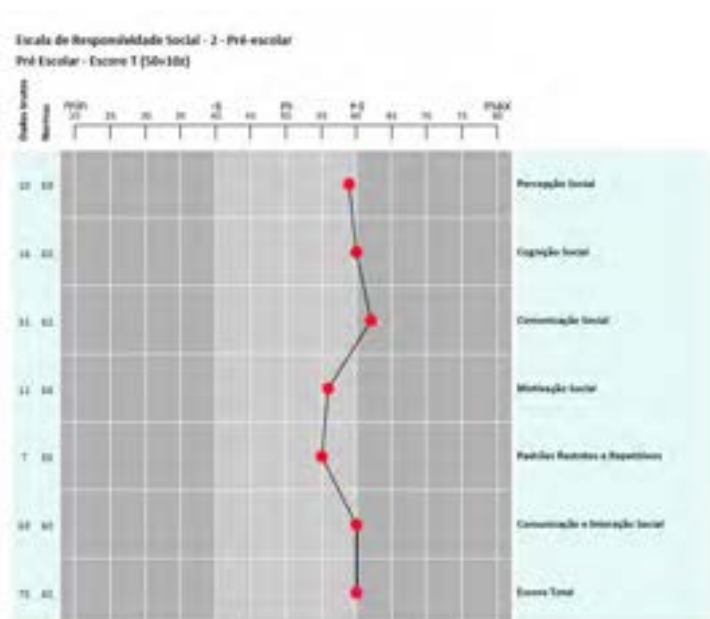
O escore total teve como pontuação (Escore T de 60) indicando que a menor apresenta comportamento social recíproco com alteração leves. **Sendo o SRS2 uma escala respondida pelos pais**, alguns comportamentos podem ser atenuados e não percebidos.

Tabela de escores T SRS- 2

Escala de Responsividade Social - 2 - Pré-escolar
Pré Escolar - Escore T (50+10z)

Escala	Pontuação bruta	Valor da norma
Percepção Social	10	59
Cognição Social	16	60
Comunicação Social	31	62
Motivação Social	11	56
Padrões Restritos e Repetitivos	7	55
Comunicação e Interação Social	68	60
Escore Total	75	60

Gráfico do Perfil geral do SRS-2:



• Escala de observação para o diagnóstico de autismo - (ADOS-2)

O ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition) é um instrumento padronizado e semiestruturado, considerado padrão-ouro para avaliação dos comportamentos relacionados à comunicação, interação social e padrões de comportamento restritos e repetitivos em indivíduos com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A escala é composta por cinco módulos (Toddler, Módulos 1, 2, 3 e 4), sendo a escolha do módulo baseada na idade cronológica e no nível de linguagem do indivíduo avaliado.

De acordo com os resultados obtidos, Ester apresentou pontuação de 05 pontos no domínio de Afeto Social (AS) e 06 pontos no domínio de Comportamentos Restritos e Repetitivos (CRR), totalizando uma pontuação global de 11 pontos. Tal pontuação situa a criança na faixa de classificação para Transtorno do Espectro Autista (TEA), indicando a presença de prejuízos clinicamente significativos nos domínios da comunicação social e padrões comportamentais restritos e repetitivos, conforme critérios estabelecidos pelo instrumento.

Os achados do ADOS-2 são consistentes com as observações clínicas e demais instrumentos aplicados, reforçando a presença de **características compatíveis com o espectro autista**.

CONCLUSÃO

Os dados obtidos por meio da anamnese, observação clínica, avaliação em ambiente escolar e instrumentos padronizados utilizados ao longo do processo avaliativo evidenciam prejuízos significativos e persistentes nos domínios da comunicação social, interação social recíproca e flexibilidade comportamental.

Ester apresenta atraso importante no desenvolvimento da linguagem verbal, dificuldades na utilização funcional da comunicação para expressão de desejos e necessidades, baixa iniciativa interativa, limitação nas trocas sociais recíprocas, tendência ao brincar solitário, resistência ao compartilhamento de interesses e dificuldades importantes na adaptação às demandas sociais e coletivas. Observam-se ainda padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses preferenciais intensos, necessidade de previsibilidade, baixa tolerância à frustração, resistência a mudanças, presença de movimentos estereotipados, alterações sensoriais e dificuldades na regulação emocional e comportamental.

Apesar das dificuldades observadas, Ester demonstra potencialidades importantes, como boa coordenação visuomotora, capacidade de compreensão de comandos simples quando mediados, interesse por estímulos musicais, habilidades de encaixe, reconhecimento de cores e possibilidade de aproximação social quando as interações respeitam seus interesses e seu tempo de resposta.

Diante da análise integrada dos achados clínicos e dos resultados obtidos nos instrumentos aplicados, o perfil apresentado por Ester é compatível com critérios diagnósticos para Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme descrito no DSM-5-TR, demandando suporte principalmente nas áreas de comunicação social, flexibilidade comportamental, desenvolvimento funcional da linguagem e adaptação social.

Ressalta-se a importância do acompanhamento multiprofissional precoce e intensivo, visando favorecer o desenvolvimento global, ampliação das habilidades comunicativas, sociais e adaptativas, bem como suporte familiar e escolar adequado às suas necessidades de desenvolvimento.

Perfil Neuropsicológico:

Transtorno do Espectro Autismo – **TEA**.

ENCAMINHAMENTOS TERAPÊUTICOS:

Intervenções seguindo as Práticas baseadas em evidências – PBE, para autismo:

Diante dos achados da avaliação, recomenda-se a manutenção e intensificação de um plano de intervenção multiprofissional e integrado, com foco no desenvolvimento global da criança, especialmente nas áreas de comunicação, interação social, comportamento e habilidades adaptativas.

✓ **Intervenção em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) realizado por psicólogo – 10 horas semanais.**

✓ **Fonoaudiologia – 2 horas semanais.**

✓ **Terapia Ocupacional (Integração Sensorial) 2 horas semanais**

✓ **Adaptações Escolares**

Recomenda-se:

- ambiente estruturado e previsível;
- uso de recursos visuais;
- mediação para interação social;
- flexibilização de demandas conforme nível de desenvolvimento;
- comunicação contínua entre escola e equipe terapêutica.
- Inserção de auxiliar de sala exclusiva.

Deixo-me a disposição para possíveis esclarecimentos.

Maceió, 11 de Maio de 2026



Maria Fabiana Lisboa

Psicóloga Clínica / Neuropsicóloga

Mestra em Educação - UNISUL

Esp. Em Educação Inclusiva

Esp. em Transtorno do Espectro do Autismo

Formação em Análise do Comportamento Aplicada

Formação no programa TEACCH Chapel Hill NC/USA

Supervisora da federação Alagoana das APAES

Coordenadora do Centro Unificado de Integração e Desenvolvimento do autista - CUIDA

CRP 15/3115





FabianaLisboa

PSICÓLOGA/NEUROPSICÓLOGA
MESTRA EM EDUCAÇÃO - UNISUL
CRP 15/3115

Psicóloga Clínica Infanto-juvenil
Analista do Comportamento – ABA
Esp. em Desenvolvimento Infantil e TEA
e Avaliação Neuropsicológica.

Evoluir Espaço Terapêutico
Rua Professor Virginio de Campos,
Nº 710, Farol. Maceió – AL.

(82) 98821-6324
@fabianalisboa3
fabianalisboa.com.br